ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi

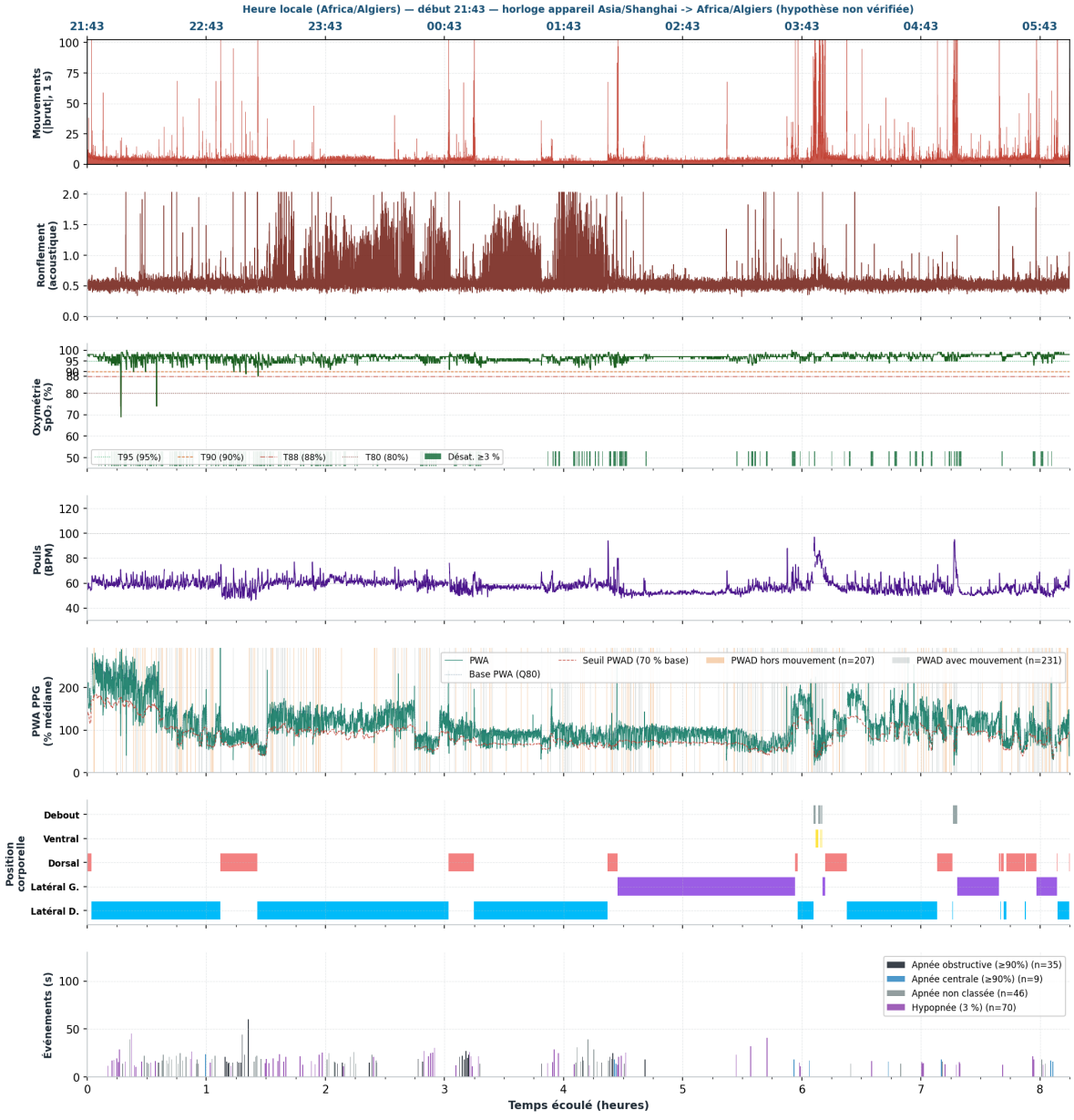
en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :	Hamidi Hocine	**ID Patient :**	20261029-148
Genre :	Homme	**Âge :**	64 ans
Taille / Poids :	177 cm / 100 kg	**IMC :**	31,9 kg/m^2
Date examen :	29/10/2026	**Indication :**	Bilan suspicion SAOS / TRS
Heure de début :	**21 :43 :00** (heure locale)	**Heure de fin :**	**05 :58 :00** (heure locale)
Durée enreg. :	495,0 min (8 h 15)	**Durée valide :**	495,0 min (100 %)

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE



v9.9-hb | 20261029-148.EDF | sha256 aeac1c69d9e8 | dénominateur : temps d'enregistrement (TRT)

FIGURE 1 – **Analyse chronologique du sommeil et des événements physiologiques (21 :43 – 05 :58).**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

Table 1 – **Répartition posturale et distribution des événements respiratoires et oxymétriques**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	75,8	15,3	16	33	5	–	30	23,7	84
Ventrale (PRO)	2,0	0,4	–	–	–	–	–	–	–
Côté gauche (LAT-G)	121,9	24,6	11	6	5	1	15	7,4	38
Côté droit (LAT-D)	290,3	58,6	56	26	40	3	98	20,3	223
Debout (Éveil)	5,0	1,0	–	–	–	–	2	24,2	2

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2

Table 2 – **Profil oxymétrique nocturne (Critère de désaturation $\geq 3\,\%$)**

Paramètre SpO_2	Valeur	Valeur de référence
SpO_2 max (%)	99	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	**69**	$\geq$ 90 %
SpO_2 moyenne (%)	97	$\geq$ 95 %
Durée totale de désaturation (min)	98,1	—
Durée moyenne de désaturation (sec)	40,6	—
Durée maximale de désaturation (sec)	101,0	—
Nombre total de désaturations (DO)	145	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	**18,1 /h**	$<$ 5 /h
Temps passé sous 95% : T95 (min / %)	48,2 min	9,8 %
Temps passé sous 90% : T90 (min / %)	**0,6 min**	**0,1 %**
Temps passé sous 85% : T85 (min / %)	0,4 min	0,1 %
Temps passé sous 80% : T80 (min / %)	0,3 min	0,1 %

2.3. INFORMATIONS DU POULS

Table 3 – **Analyse de la fréquence de pouls / cardiaque nocturne**

Paramètre Pouls / Fréquence Cardiaque	Valeur (bpm)
Fréquence cardiaque maximale (FC max)	97
Fréquence cardiaque minimale (FC min)	46
Fréquence cardiaque moyenne (FC moy)	57,6

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

Table 4 – **Détail et quantification des événements respiratoires**

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)
Apnées (AP)		
Nombre total	119	
– Obstructives (SAOS)	65	(7,9)
– Centrales (AC)	50	(6,1)
– Mixtes (AM)	4	(0,5)
Durée totale (min)	29,9	
Durée moyenne (sec)	15,1	
Durée maximale (sec)	27,0	
Hypopnées (HYPO)		
Nombre total	83	
Durée totale (min)	30,3	
Durée moyenne (sec)	21,9	
Durée maximale (sec)	99,6	
Total Événements Respiratoires (TER)		
Nombre total (AP + HYPO)	202	—
Durée totale (min)	60,2	—
Durée moyenne (sec)	17,9	—
IAH (Indice Apnées-Hypopnées)	—	**24,5**
IDO (Index Désaturations)	—	**18,1**
IMR / RDI (Respiratory Disturbance Index)	—	**24,5**

Règles AASM : Hypopnée définie par une réduction de débit $\geq 30\,\%$ *pendant* $\geq 10\,s$ *associée à une désaturation* $\geq 3\,\%$*. Indices calculés sur le temps d'enregistrement valide (495,0 minutes).*

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

Table 5 – **Synthèse générale des paramètres polygraphiques**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moyenne (%)	97	SpO_2 minimale (%)	**69**
IDO (/h)	18,1	Nombre SAOS	65
Nombre AC	**50**	Nombre AM	4
IA (/h)	14,4	Nombre HYPO	83
IH (/h)	10,1	**IAH (/h)**	**24,5**
IMR / RDI (/h)	24,5	Index Ronflements (/h)	1,0
FC moyenne (bpm)	57,6	Nb changements position	**128**

4. AVIS MÉDICAL

4.1. Interprétation des Résultats

Polygraphie ventilatoire nocturne de **495,0 minutes** (8 h 15 min, 100 % analysable ; 21h43 – 05h58). Les indices sont calculés sur le temps d'enregistrement.

— **Sévérité :** IAH = **24,5 /h** (IA = 14,4 /h ; IH = 10,1 /h), ce qui correspond à un **SAOS d'intensité modérée** (15 à 29,9 /h).

— **Nature des événements :** sur 119 apnées, on compte 65 obstructives (54,6 % ; 7,9 /h), **50 centrales** (42,0 % ; **IAC = 6,1 /h**) et 4 mixtes (3,4 %). Les apnées centrales représentent environ un quart (24,8 %) des 202 événements respiratoires : la composante centrale est significative (IAC > 5 /h) mais **non prédominante**, et ne répond pas aux critères d'un syndrome d'apnées centrales du sommeil (centrales > 50 % des événements). Il s'agit d'apnées brèves (durée moyenne des apnées 15,1 s, maximum 27 s).

— **Effet positionnel :**

  — *Décubitus dorsal* (15,3 % du temps) : 54 événements en 75,8 min, soit un IAH ≈ **43 /h** ; IDO = 23,7 /h.

  — *Décubitus latéral gauche* (24,6 %) : IAH ≈ 11 /h ; IDO = 7,4 /h.

  — *Décubitus latéral droit* (58,6 %, position dominante) : IAH ≈ **26 /h** ; IDO = 20,3 /h ; il concentre **40 des 50 apnées centrales** (IAC ≈ 8,3 /h).

  L'IAH hors décubitus dorsal reste à ≈ **21 /h** (rapport dorsal/non dorsal ≈ 2) : la composante positionnelle est réelle mais **non exclusive** et n'explique pas à elle seule la sévérité globale.

— **Retentissement oxymétrique :** IDO = **18,1 /h** (145 désaturations ≥ 3 %). La SpO_2 moyenne est de 97 % avec un T90 de 0,6 min (0,1 %) : il n'y a **pas d'hypoxémie nocturne soutenue**. Le nadir à **69 %** est très bref (T80 = 0,3 min) ; il témoigne d'une désaturation transitoire sévère.

— **Fréquence cardiaque et motricité :** FC moyenne de 57,6 bpm (extrêmes 46 – 97), dans les limites physiologiques du sommeil. Les **128 changements de position** (≈ 15,5 /h) peuvent traduire une fragmentation du sommeil, éventuellement en lien avec les événements respiratoires.

Dr. Bakha

4.2. Conclusion Diagnostique

— **SAOS d'intensité modérée** (IAH = **24,5 /h**), à prédominance obstructive.

— **Composante centrale significative mais non prédominante** (50 apnées centrales ; IAC = **6,1 /h** ; ≈ 25 % des événements), surtout en décubitus latéral droit.

— **Aggravation en décubitus dorsal** (IAH ≈ 43 /h) sans caractère exclusif : IAH hors décubitus dorsal ≈ 21 /h.

— **Désaturations intermittentes** (IDO = 18,1 /h), sans hypoxémie soutenue (T90 = 0,1 %) ; nadir bref à **69 %**.

Conduite à tenir recommandée :

1. **Exploration de la composante centrale :** recherche d'une cause (insuffisance cardiaque, fibrillation atriale, AVC, insuffisance rénale, médicaments).
2. **Traitement, selon la symptomatologie et le terrain :**
   — **PPC autopilotée** si l'indication est retenue, avec contrôle de l'efficacité à 1 – 3 mois (IAH résiduel, fuites, **apnées centrales résiduelles ou émergentes sous PPC**).

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24

Dr. Bakha